

FORMACIÓN DEL INDIVIDUO

Naturaleza o crianza

Capacidad para aprender

FLUIDEZ PSICOLÓGICA

Dicotomía: Entre la depresión y la ansiedad

FLUIDEZ PSICOLÓGICA

De acuerdo con Csikszentmihalyi, la fluidez psicológica es un estado en el que confluyen un sentido de que se puede lograr lo extraordinario y las competencias duramente adquiridas con muchos años de práctica. Es disfrutar haciendo lo que sabe uno hacer mientras se contribuye a algo que está más allá de uno mismo.

Daniel Kahneman describe la fluidez psicológica como un estado óptimo de motivación intrínseca en el que la persona está inmersa en lo que está haciendo, caracterizado por una sensación de gran libertad, gozo y compromiso durante la cual se ignoran las necesidades temporales de sueño y alimento y el ego desaparece.

Es posible mejorar la calidad de vida si el estado de fluidez se experimenta con cierta frecuencia en la cotidianeidad. En una misma circunstancia, una persona puede encontrar retos maravillosos y otra decir que no hay nada que hacer. Esto es lo que distingue a los visionarios de los ordinarios.

El estado de fluidez se caracteriza por una sensación de enfocar la energía, implicándose totalmente en la tarea, y tener éxito en la realización de la actividad.

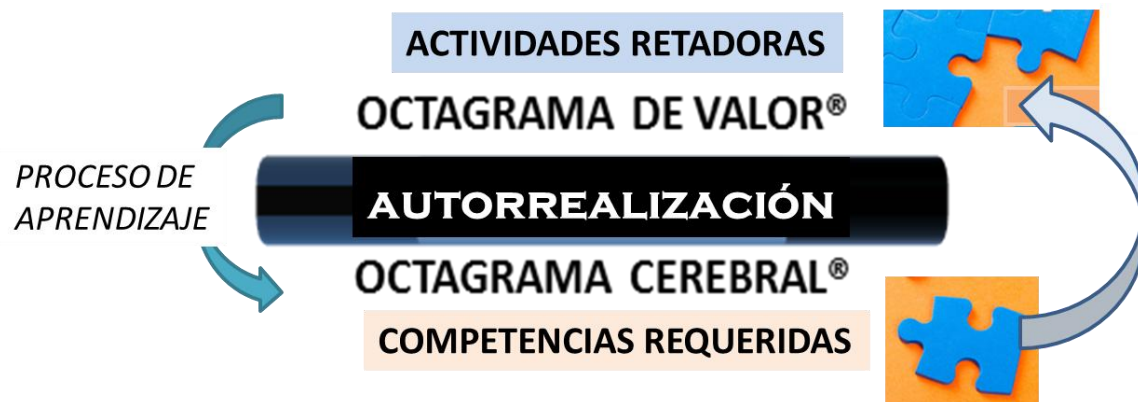
Prácticamente cualquier actividad puede producir un estado de fluidez psicológica, con tal de que se den los factores adecuados.

Las condiciones para la fluidez psicológica son: metas claras, retroalimentación y balance entre retos y capacidades. Estas condiciones juegan un papel extremadamente importante en el lugar de trabajo.

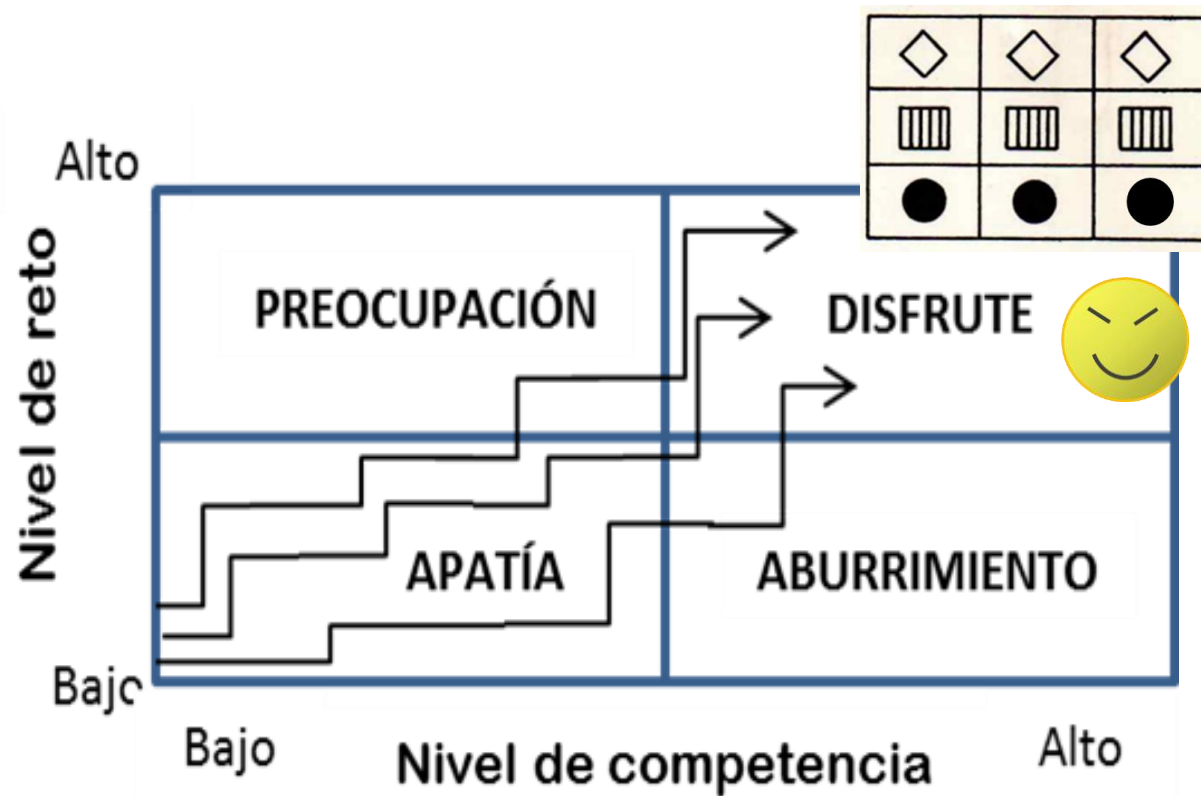
La fluidez está asociada al logro y por lo tanto tiene implicaciones en la satisfacción y realización de los empleados y en la empresa se pueden crear las condiciones propicias para que la gente obtenga a través del flujo recompensas intrínsecas que fomenten su persistencia para alcanzar resultados. Desarrollar y dominar ciertas destrezas y disfrutar con aplicarlas son causas de felicidad.

Cuando un ejecutivo cuenta sobradamente con las competencias requeridas para afrontar los retos más difíciles de su puesto de trabajo, está en condiciones de disfrutarlo y posiblemente alcanzar estados de fluidez.

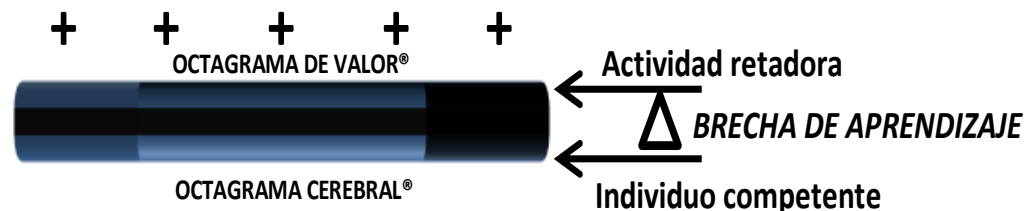
La autorrealización implica empatar las actividades con alto grado de dificultad modeladas en el Octagrama de Valor®, con las competencias requeridas para realizarlas, modeladas en el Octagrama Cerebral®.



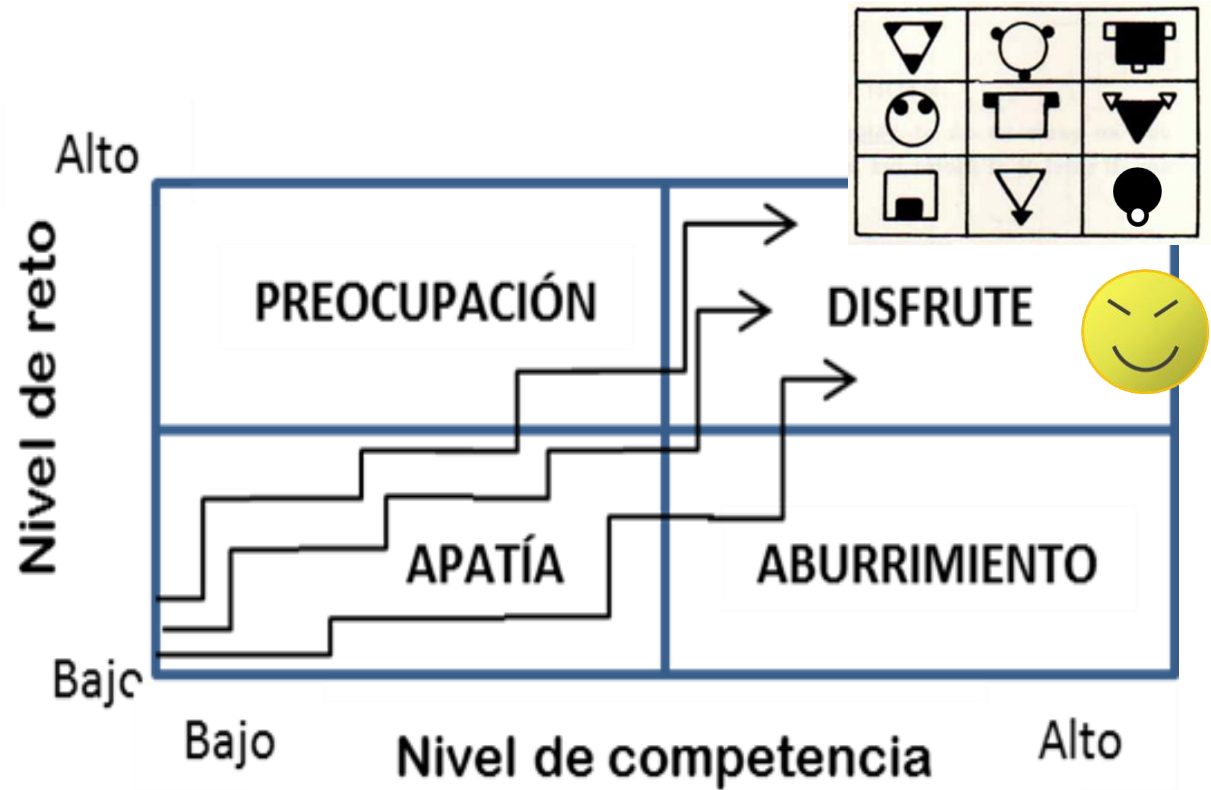
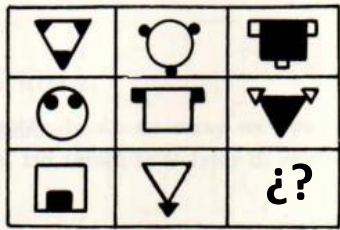
◊	◊	◊
●	●	¿?



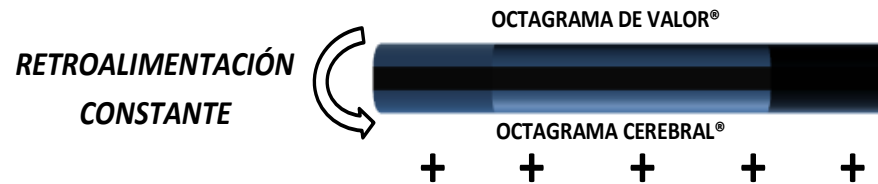
Conforme se hacen más eficientes los procesos, aumenta el reto o dificultad para realizarlos y por lo tanto las habilidades y destrezas requeridas. Se crea una tensión positiva en el Octagrama de Valor®.



Las actividades en el Octagrama de Valor®, representan retos con cierto grado de dificultad que el ejecutivo asume para que la organización en su conjunto sea exitosa y competitiva. En el ejercicio de sus funciones, el ejecutivo busca satisfacer sus propios intereses de desarrollo de sus potencialidades, pero al mismo tiempo colabora en el cumplimiento de los objetivos de la empresa.



Para reducir la brecha, los dueños de los procesos ejercitan sus competencias y las perfeccionan a un nivel que excede lo requerido. Entonces la tensión positiva se genera en el Octagrama Cerebral®.



Como se ha mencionado, debe existir un buen balance entre los retos que presenta la actividad y las habilidades requeridas para llevarla a cabo y es precisamente esta condición la que empata las competencias del Octagrama Cerebral® con las actividades del Octagrama de Valor®. Si el match es bueno, entonces el empleado se sumergirá en estados de fluidez que le producirán una sensación placentera.

En el proceso de elevar la dificultad del reto conforme se desarrollan las competencias, es importante cuidar los extremos: Por un lado, hay que evitar la depresión (demasiado aburrido) y por el otro, la ansiedad (demasiado difícil). Se requiere un balance entre la dificultad del reto y el grado de competencia adquirida.

La línea entre la salud y la enfermedad mental es muy delgada. Tenemos que elevar los retos, pero no excesivamente como para pasar de la preocupación a la **ansiedad** ni tampoco esperar a dominarlos tanto como para pasar del aburrimiento a la **depresión**.

▽	○	☐
☺	☐	▽
☐	▽	¿?



Alto

Nivel de reto

▽	○	☐
☺	☐	▽
☐	▽	○

PREOCUPACIÓN

X

APATÍA

DISFRUTE

ABURRIMIENTO

X



Bajo

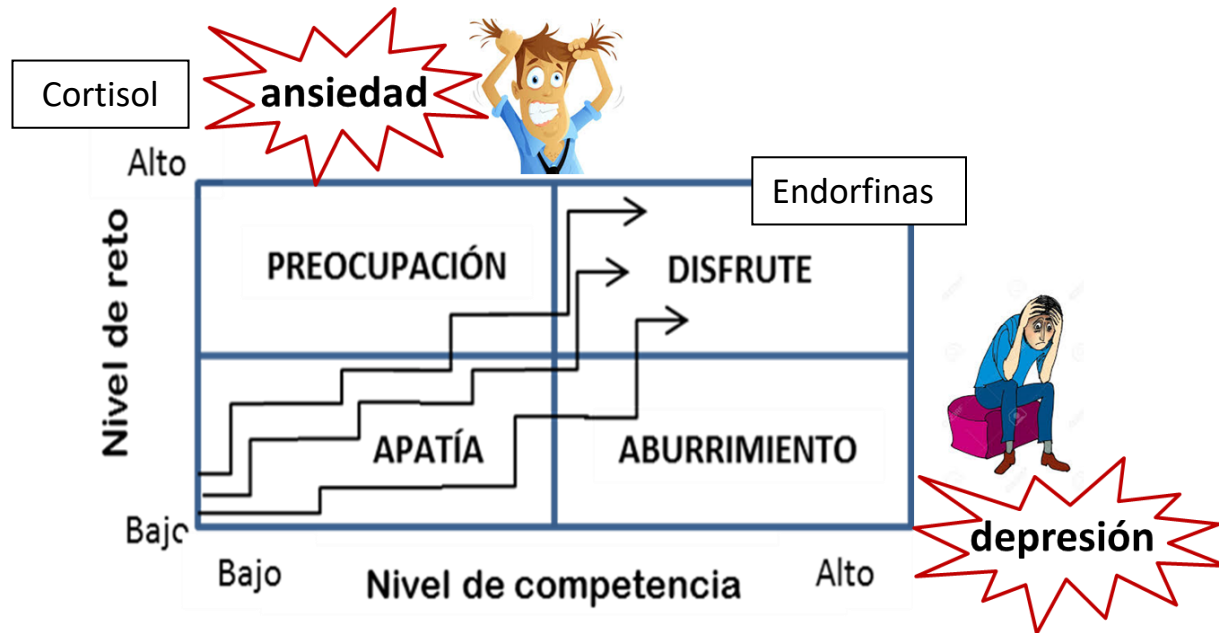
Bajo

Nivel de competencia



Alto

◇	◇	◇
●	●	¿?



En el proceso de elevar la dificultad de un reto conforme se desarrollan las competencias, es importante cuidar los extremos: Por un lado, hay que evitar la depresión (demasiado aburrido) y por el otro, la ansiedad (demasiado difícil). Se requiere un balance entre la dificultad del reto y el grado de competencia adquirida.

ENTRE LA DEPRESIÓN Y LA ANSIEDAD

Con fortaleza de voluntad, las personas pueden regular hasta cierto punto la intensidad con la que se manifiestan los rasgos del carácter.

Cuando alguno de los rasgos se dispara hacia un extremo – ausencia absoluta o presencia total – se tiene un desorden de emocional.

¿Qué tan delgada es la línea entre la salud mental
y la enfermedad?

Todos experimentamos tristeza y angustia de vez en cuando, pero cuando se convierten en excesivas o inapropiadas para el contexto y circunstancia, nos movemos de lo normal a lo patológico.

Emociones no controladas se convierten en desórdenes emocionales.

EMOCIÓN NORMAL		DESORDEN EMOCIONAL
Tristeza (100%)	→	(9.5%*) Depresión
Angustia (100%)	→	(14.3%*) Ansiedad

* Porcentaje de personas que lo padecen

La amígdala tiene más influencia sobre el córtex que el córtex sobre la amígdala, lo que implica que la excitación emocional domine y controle el pensamiento.

Decirse a uno mismo que no debería estar ansioso o deprimido no ayuda mucho.

En el futuro los seres humanos podrían ser más capaces de controlar sus emociones, si la evolución los dotara de conexiones corticales más fuertes con la amígdala y así cognición y emoción trabajarían juntas y no por separado.

Cuando el sistema emocional se suelta de los controles corticales que mantienen en cintura nuestros impulsos primitivos, sufrimos desórdenes como la depresión y la ansiedad.

UNA DICOTOMÍA: PSICOSIS Y NEUROSIS

La **psicosis** es una *enfermedad mental* en la que el aquejado piensa que no está enfermo, sino que las personas están en contra de él o quieren engañarlo. El paciente está alejado de la realidad e imagina algo más grave de lo que en realidad está sucediendo, pudiendo llegar a alucinar o delirar.

La **neurosis** es un *trastorno psíquico* de personas que están en la realidad, conscientes de su condición. Sus respuestas emocionales son exageradas con respecto a lo que las provocó, y muy difíciles de controlar. Los síntomas asociados son angustia, nerviosismo y ansiedad.

Prevalencia de diversos trastornos psicológicos en EUA.

PSICOSIS	Desórdenes afectivos	9.5%	Depresión mayor	6.7%
			Desorden distímico	1.5%
			Desorden bipolar	2.6%
NEUROSIS	Desórdenes de ansiedad	18.1%	Desorden de pánico	2.7%
			Estrés post-traumático	3.5%
			Ansiedad generalizada	3.1%
			Fobia social	6.8%
			Fobia específica	8.7%

Fuente principal: US Public Health Service. La suma de porcentajes puede no coincidir con el total, ya que cualquier persona pudo haber sido diagnosticada con dos o más padecimientos.

¿POBLACIÓN “NORMAL”: 72.4%?

Las **neurosis** afectan en mayor grado la percepción del sujeto sobre sí mismo y sus relaciones con el entorno social y familiar más cercano, pero generalmente no presentan síntomas de desconexión con la realidad ni tampoco un alejamiento demasiado amplio de la vida social, por lo que los neuróticos pueden desempeñarse laboral y académicamente bien.

Las **psicosis** abarcan una manifestación más claramente asociada a la desconexión con la realidad y un aplanamiento afectivo severo. Los síntomas de las psicosis incluyen alucinaciones, delirios, una grave alteración afectiva y relacional, y otros factores como los trastornos depresivos y bipolares, los cuales pueden tener graves repercusiones personales, familiares y sociales que afectan el desempeño laboral.

NEURÓTICO

Conectado con la realidad

Pueden desempeñarse laboral y académicamente bien.

PSICÓTICO

Desconectado de la realidad

Afectados en el desempeño en el trabajo.

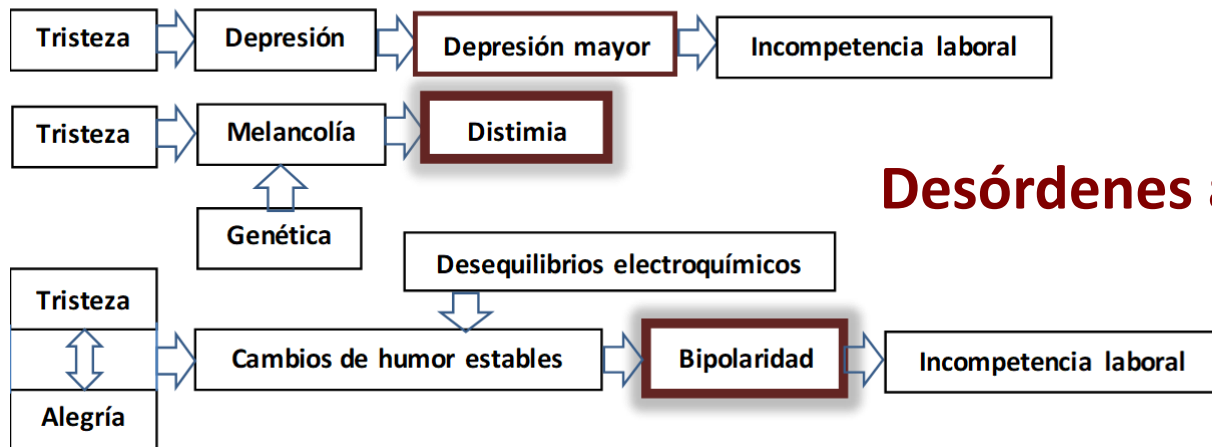
DESÓRDENES AFECTIVOS

Las emociones pueden volverse en contra nuestra cuando las desarrollamos en el modo no adaptativo, es decir, cuando la expresión emocional no está en consonancia con la situación.

Un ejemplo es la tristeza que nos ayuda a adaptarnos a las pérdidas que vamos teniendo en la vida (lado adaptativo), pero la tristeza desproporcionada, tanto en tiempo como en intensidad, lleva a la depresión (lado no adaptativo).

“La depresión es una prisión en la que eres tanto el prisionero como el cruel carcelero”. Dorothy Rowe

La tristeza es una emoción que se manifiesta en todos los seres humanos en determinadas ocasiones, pero la **depresión mayor** es una enfermedad mental, caracterizada por provocar un abatimiento patológico e incapacidad para disfrutar.



Desórdenes afectivos.

La **distimia** o mal humor, es un trastorno afectivo crónico caracterizado por baja autoestima y un estado de ánimo melancólico, triste y apesadumbrado, pero que no llega a ser depresión. El origen de la distimia es genético-hereditario y en su desarrollo influyen factores psicosociales como el desarraigo y la falta de estímulos en la infancia.

La **bipolaridad** es una psicosis maníaco-depresiva, caracterizada por la presencia de uno o más episodios con niveles anormalmente elevados de energía y estado de ánimo y causada por un desequilibrio electroquímico en los neurotransmisores cerebrales. El elemento básico para el tratamiento del trastorno bipolar es la toma de conciencia del problema y su conocimiento por parte del afectado y sus allegados.

La depresión puede tener importantes consecuencias sociales y personales, desde la incapacidad laboral en forma de desgano para la productividad hasta la falta de interés hacia uno mismo, lo cual afecta también a los individuos que rodean a quien la sufre.

El origen de la depresión es múltiple, aunque hay que destacar factores desencadenantes como una decepción sentimental, la vivencia de un accidente o recibir malas noticias. Otros orígenes incluyen factores de predisposición genéticos o de condicionamiento educativo.

Las depresiones mayores se tratan con antidepresivos que actúan sobre la re-captación de los tres principales neurotransmisores que intervienen en la depresión, a saber, la serotonina, la dopamina y la noradrenalina.

DESÓRDENES DE ANSIEDAD

Todo el tiempo estamos evaluando el riesgo y planeando cómo maximizar nuestras ganancias y minimizar nuestras pérdidas.

El cerebro pondera una situación, genera un conjunto de cursos de acción potenciales, predice los posibles resultados de estas acciones, les asigna prioridades y elige una en particular.

Estas actividades son funciones cognitivas complejas que permiten pasar de la reacción a la acción y entonces, al involucrarse la corteza prefrontal, nos convertimos en actores, ya no sólo reactores. Pero el costo de esto puede ser la ansiedad.

El **miedo** es una emoción que se expresa cuando se activa el mecanismo de defensa que nos ha permitido sobrevivir a los seres humanos por decenas de miles de años.

Cuando el sufrimiento y preocupación son provocados por un peligro o una amenaza desconocidos, aparece la **angustia**, que es una emoción diferente a la del miedo.

Cuando el nivel de angustia es elevado y persistente, se puede instalar un estado de ansiedad psicopatológico que requiere ser atendido con terapias psicoanalíticas y tratamientos farmacológicos, entre otros. Para el tratamiento de la ansiedad se usan los ansiolíticos o tranquilizantes menores que son fármacos que tienen una acción depresora del sistema nervioso central.

El **estrés** es la anticipación o experiencia de una dificultad o adversidad.

La respuesta al estrés incluye la activación del sistema nervioso simpático (pelea o huye), la inhibición del sistema nervioso parasimpático (descansa y digiere) y la liberación de adrenalina y cortisol. Todo esto nos pone alertas y listos para responder física o mentalmente a lo que venga.

Sin embargo, cuando el estrés se apodera de nosotros, el cerebro no procesa adecuadamente la información sensorial que llega a través de los sentidos y entonces reaccionamos con impulsividad (damos gritos).

La hormona del estrés es el **cortisol**.

Responde al peligro, como la noradrenalina, pero su papel es protegernos y repararnos.

Las pruebas más comúnmente usadas para determinar el estrés son la medición directa de la cantidad de cortisol en la saliva y las evaluaciones psicológicas de ansiedad a partir de la aplicación de cuestionarios.

El estrés puede afectar el sistema inmunológico para bien o para mal. La hormona puede crear lucidez mental y contribuir a un sentido de logro al superar obstáculos, pero si el estrés es demasiado intenso o prolongado como para elevar el nivel de los esteroides adrenales puede causar daños al hipocampo, alterando sus funciones de memorizar.

Investigaciones recientes apuntan en el sentido de que una actitud positiva hacia el estrés induce niveles óptimos de cortisol y consecuencias psicológicas positivas.

Se sabe que el **sentido de control** es un componente psicológico que reduce el estrés y los directivos de más alto rango experimentan en mayor medida esta sensación, así que quienes dirigen experimentan menos estrés que los dirigidos.

La gente con menores niveles de ansiedad es idónea para ocupar posiciones de liderazgo. La clave para reducir el estrés es alcanzar suficiente autoridad para delegar la supervisión de los subordinados a los gerentes medios.

Mientras el efecto de la dopamina dura de 2 a 4 horas, el del cortisol puede durar hasta 24. Por esta razón, los empleados deben recibir por lo menos cuatro halagos genuinos de su trabajo por cada retroalimentación negativa para crear un balance en el que se sientan bien tratados.

Cuando se eleva la barrera de retos, también se está elevando la de la motivación y recompensa intrínsecas, siempre y cuando los empleados se sientan empoderados, competentes, respaldados y apreciados por aceptar ese reto.

CONCLUSIONES

El buen desempeño laboral depende de un equilibrio entre reto y capacidad y de una buena dosis de retroalimentación que induzca el aprendizaje.

Los colaboradores en una organización deben cuidar su salud mental y tiene que haber programas de capacitación que atiendan este aspecto.

El estrés puede ser un factor discapacitante, por lo que debe atenderse oportunamente.